

Veille Cardio ♥ Nouveautés de la semaine

Semaine du 22 août 2026

4 nouveautés cette semaine — aucune ne modifie la pratique dans l'immédiat.

PRÉVENTION **À connaître** Analyse d'essai randomisé · CLEAR Outcomes

Bempedoic Acid and First and Recurrent Limb Outcomes in Statin-Intolerant Patients With Peripheral Artery Disease: Insights From the CLEAR Outcomes Trial

Circulation · 18 août 2026

Chez les 1 624 patients artéritiques de l'essai CLEAR Outcomes (tous intolérants aux statines), l'acide bempédoïque réduit d'environ un tiers les événements graves du membre inférieur (8,3 % → 5,8 %, $p = 0,018$) et de 45 % le nombre total d'événements, avec un bénéfice visible dès 6 mois.

Au cabinet : argument utile devant l'artéritique « intolérant aux statines », situation fréquente et souvent laissée sans traitement hypolipémiant efficace. L'acide bempédoïque (seul ou associé à l'ézétimibe) n'est plus seulement un moyen de faire baisser un chiffre de LDL : il y a maintenant un signal sur le devenir du membre. Rappel de méthode : avant de conclure à une intolérance, retester une autre statine à faible dose ou en discontinu.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)**RYTHMOLOGIE** **À connaître** Mesures de qualité AHA/ACC

2026 AHA/ACC Clinical Performance and Quality Measures for Patients With Atrial Fibrillation

JACC · 18 août 2026 · document AHA/ACC (remplace 2016 et 2020)

Nouveau référentiel américain de qualité des soins dans la FA : 5 mesures de performance et 16 mesures de qualité, dont 3 des 5 et 14 des 16 sont inédites. Nouveauté majeure : une mesure de performance dédiée à la *prise en charge globale* (mode de vie, comorbidités), à côté du bilan initial standardisé, de la documentation du risque embolique et de la prescription d'AOD.

Au cabinet : excellente grille d'auto-évaluation de votre consultation FA. Concrètement : vérifier que chaque FA nouvelle a bien eu ETT + biologie + TSH, que le score embolique est écrit dans le courrier, et surtout ne pas s'arrêter à l'anticoagulation — la consultation FA « complète » inclut désormais poids, alcool, activité physique, apnées du sommeil et pression artérielle.

[Article original](#) · [Analyse ACC](#) · [Analyse TCTMD](#)**RYTHMOLOGIE** **À connaître** Cohorte prospective IRM · 550 patients

Impact of Myocardial Fibrosis and Female Sex on Life-Threatening Arrhythmias and Sudden Cardiac Death in Mitral Valve Prolapse

Circulation: Cardiovascular Imaging · août 2026

550 patients porteurs d'un prolapsus mitral explorés par IRM cardiaque et suivis 4,4 ans : le sexe féminin et la fibrose myocardique multiplient chacun par plus de 3 le risque d'arythmie grave, et se cumulent — 76,5 % de survie sans événement à 5 ans chez les femmes avec fibrose contre 98,5 % chez les hommes sans fibrose.

Au cabinet : face à un prolapsus mitral, ne pas se contenter d'évaluer la fuite. Chez une femme, a fortiori si palpitations, syncope, extrasystoles ventriculaires nombreuses, ondes T négatives inférieures ou disjonction de l'anneau à l'écho, l'IRM cardiaque avec recherche de fibrose devient un argument fort pour orienter vers le rythmologue — le seul critère de sévérité de la régurgitation sous-estime le risque rythmique chez la femme.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)

CHAMPION-AF and CLOSURE-AF: reconciling contrasting results

European Heart Journal · 20 août 2026 · Viewpoint (Omerovic & Redfors)

Mise en perspective des deux grands essais 2026 de fermeture d'auricule gauche, déjà signalés ici, dont les conclusions semblent opposées : les auteurs montrent que les distributions d'effet se recouvrent largement et que l'étiquette « essai positif » ou « négatif » est surtout une convention qui, ensuite, gouverne l'adoption clinique. Ils plaident pour des randomisations sur registre après commercialisation, sous gouvernance publique indépendante.

[Article original](#)

Tableau de bord complet (65+ sorties, recherche FR/EN, fiches de lecture) : hacuubo.github.io/veille-cardio

Fiches rédigées par Claude — à valider par le lecteur avant toute application clinique.